



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SELASA, 02 SEPTEMBER 2025
PUKUL : 16.00 WIB
JENIS MEETING : SHARING ILMU KEGAWATDARURATAN BEDAH SYARAF
TEMPAT : ZOOM MEETING

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Cidera Kepala/Brain injury
	Masalah : Derajat Brain injury
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Klasifikasi brain injury didasarkan pada penilaian GCS terlepas dari ada/tidaknya penyulit lain 2. Cidera Kepala Ringan: GCS 13-15, Cidera Kepala Sedang: 12-9, Cidera Kepala Berat: GCS < 9 3. GCS sangat menentukan tatalaksan yang akan dilakukan 4. Cidera otak traumatik jika ada pengaruh external
No	Penjelasan
2	Pokok Bahasan : Cidera Kepala/Brain injury
	Masalah : Etologi Cidera otak
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut: 1. Sistemik: hipoksia, hipotensi, hipo/hiperglikemi, hipertermia, Gangguan elektrolit, gangguan koagulasi, infeksi 2. Intrakranial: Peningkatan TIK, Edema otak, Kejang, Iskemia
No	Penjelasan
3	Pokok Bahasan : Cidera Kepala/Brain injury
	Masalah : Tatalaksana
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Penanganan cidera otak primer 2. Mencegah dan menangani cidera otak sekunder 3. Optimalisasi metabolisme otak 4. Rehabilitasi 5. Indikasi rawat inap: a) Kebingungan atau riwayat pingsan/penurunan kesadaran b) Keluhan dan gejala neurologik, termasuk nyeri kepala menetap dan muntah c) Kesulitan dalam penilaian klinis, misalnya pada alkohol, epilepsi d) Kondisi medik lain: gangguan koagulasi, diabetes mellitus e) Fraktur tengkorak f) CT scan abnormal g) Tak ada yang dapat bertanggung jawab untuk observasi di luar rumah sakit h) Umur pasien diatas 50 tahun i) Anak-anak j) Indikasi sosil
No	Penjelasan
4	Pokok Bahasan : Cidera Kepala/Brain injury
	Masalah : Indikasi memulangkan pasien
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut



	1. Sadar dan orientasi baik, tidak pernah pingsan 2. Tidak ada gejala neurologis 3. Keluhan berkurang, muntah atau nyeri kepala hilang 4. Tak ada fraktur kepala atau basis kranii 5. Ada yang mengawasi di rumah 6. Tempat tinggal dalam kota 7. Edukasi keluarga terkait kondisi pasien
No	Penjelasan
5	Pokok Bahasan :Brain Injury ec Trauma
	Masalah : Pemeriksaan penunjang
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Pada Dewasa salah satu dari kriteria: a) Usia > 65 Tahun b) Mekanisme trauma yang berbahaya c) Muntah > 1x d) Amnesia > 30 menit e) GCS < 15 pada saat 2 jam f) Curiga ada fraktur basis kranii, fraktur terbuka dan fraktur depresi 2. Pada anak < 2 tahun: a) GCS <14 atau Perubahan Status Mental b) Mekanisme Trauma yang Berat c) Hilang Kesadaran > 5 Detik d) Hematoma Temporal, Parietal, atau Oksipital e) Fraktur Kepala yang Dapat Teraba f) Nampak Berperilaku Abnormal Menurut Orang Tua
No	Penjelasan
6	Pokok Bahasan : Pendarahan Otak
	Masalah : Indikasi operasi dan edukasi terkait operasi
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Anamnesa harus digali terkait kondisi pasien terutama jika terdapat tanda-tanda kecurigaan peningkatan TIK (muntah proyektil, nyeri kepala, papil edema) komorbid: HT, riwayat trauma dsb 2. EDH: Tebal 1.5 cm, MLS 0.5 cm, Volume > 30 cc 3. SDH: Tebal 1 cm, MLS 0.5 cm, Volume: - 4. ICH: Tebal: -, MLS: 0.5 cm, Volume 20 cc – 50 cc 5. Sampaikan ke keluarga terkait apabila dilakukan operasi: indikasi dilakukan tindakan, resiko tindakan, komplikasi tindakan dan metode tindakan.
No	Penjelasan
7	Pokok Bahasan : Fraktur basis kranii
	Masalah :
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut Tanda klasik FBK adalah 1. Ekimosis periorbital, 2. Hemotimpani, 3. CSF rhinorrhoea/otorrhoea dan Battle's sign. 4. Gangguan fungsi saraf tergantung pada lokasi fraktur. Jenis Fraktur 1. Fraktur linier 2. Fraktur depresi 3. Fraktur comminuted 4. Fraktur diastasis 5. Fraktur diastasis dalam 3D
No	Penjelasan



8	Pokok Bahasan : Primary Survey
	Masalah : Primary survey pada kasus Bedah Syaraf
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Pada kasus terutama kasus trauma harus dilakukan primary survey. GCS dan primary survey menjadi hal yang sangat krusial dalam tindakan yang akan dilakukan 2. Tatalaksana disesuaikan dengan temuan pada saat pemeriksaan primary survey 3. Jika terdapat luka dengan pendarahan bisa dilakukan primary survey dan pertimbangan jahit situasional jika memang diperlukan.
No	Penjelasan
9	Pokok Bahasan : Rujukan Bedah Syaraf
	Masalah : Kapan dapat rujukan dapat dilakukan di RSPHM
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. GCS menjadi hal pertama yang menjadi pertimbangan 2. Hasil penunjang juga menjadi pertimbangan apakah pasien bisa dilakukan tindakan atau tidak. 3. Apabila ada rujukan terkait BS maka bisa konsulkan dahulu dan DPJP akan mempertimbangkan kondisi ini 4. Tentukan kebutuhan untuk merujuk, konsultasi, MRS, atau KRS pada pasien. 5. Lakukan konsultasi dengan bedah saraf sedini mungkin. 6. Jika ahli bedah saraf tidak tersedia di tempat, lakukan perujukan pasien dengan cedera otak sedang atau berat.
No	Penjelasan
10	Pokok Bahasan : Open wound
	Masalah : Batasan tatalaksana pada vulnus antara bedah syaraf dan bedah plastik
	Keterangan :
	PIC : Dokter IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Pada alis keatas ditangani oleh bedah syaraf dan alis ke bawah dengan bedah plastik 2. Kecuali ada pertimbangan apabila luka disertai dengan bone expose jika lokasi diatas alis maka pertimbangan dilakukan oleh bedah plastik

Pemimpin Rapat
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 02 September 2025

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatanganan Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Amada Firmandani